

간암 진단 첫 30일

간기능과 병기를 함께 보는 치료 흐름

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 10

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

간암 치료는 ‘암’과 ‘남은 간의 힘’을 함께 봅니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Hepatocellular Carcinoma, Version 2.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용**만 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 영상 진단, 간기능, 병기

30초 요약

- 간경변이나 B·C형 간염이 있는 고위험군에서는 **전형적인 영상 소견만으로 간암을 진단**할 수 있습니다. 조직검사가 늘 필요한 것은 아닙니다.
- 치료는 **종양(크기·개수·혈관 침범·전이) + 남은 간의 힘(간기능) + 전신상태**를 함께 보고 정합니다.
- 간암의 원인(B형간염·음주 등)을 누구 탓으로 돌리는 것은 치료에 도움이 되지 않습니다. **지금부터의 간 보호**가 중요합니다.
- **B형간염 항바이러스제는 끊지 않고 계속**(바이러스를 잘 억제하면 간암 치료 후 재발 위험이 줄어든다는 연구가 있습니다), **C형간염은 치료 전이라면 항바이러스 치료(대개 8~12주 먹는 약) 시기를 상의**하는 것이 간암 치료의 일부입니다.

판독지에 LR-숫자가 있다면(LI-RADS)

범주	뜻
LR-5	간세포암 확실 범주
LR-4	가능성 높음 — 추가 검사·조직검사·짧은 추적 논의
LR-3	간세포암 가능성 중간 — 대개 짧은 간격으로 추적 영상
LR-M	간세포암 외 악성 가능성 — 조직검사 고려
LR-TIV	혈관 안 종양(종양혈전)

오늘 물어볼 질문

1. 제 간암은 영상으로 진단됐나요, 조직으로 확인됐나요?
2. 제 간기능(Child-Pugh·ALBI)은 어느 정도인가요?
3. 제 병기(BCLC·mUICC)는 무엇인가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- 갑자기 생긴 심한 배 통증 + 어지럼·쓰러질 것 같음(간암 파열 가능성) → 119 또는 즉시 응급실, 직접 운전 금지
- 피를 토하거나 검은 변(정맥류 출혈) → 119
- 낮밤이 바뀌고 멍함, 헛소리, 손 떨림(간성뇌증) — 보호자가 먼저 알아차리는 경우가 많음
- 배가 빠르게 불러오고 열·복통(복수 감염)
- 황달이 빠르게 진해짐
- 시술 후 고열이 지속되거나 다시 오름, 진통제로 조절되지 않는 통증
- 전신치료(면역치료·표적치료) 중 **38°C 이상 발열**, 숨참·기침, 하루 4회 이상 설사 → 해열제·지사제보다 먼저 치료팀에 연락
- 등 통증 + 다리 힘 빠짐·대소변 장애(척수 압박)
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 간암 파열은 내부 출혈로 생명이 위험할 수 있습니다.
2. 간경변 환자의 토혈·흑변은 정맥류 출혈일 수 있습니다.
3. 멍함·혼동은 마음 문제가 아니라 **간 문제(간성뇌증)**일 수 있어 락툴로오스 등 처방약을 임의로 끊지 말고 연락합니다.
4. 복수에 열이 나면 복막염 가능성이 있습니다.
5. 시술 후 열·통증이 수일 내 가라앉지 않으면 연락합니다.

6. 척추 전이에 의한 신경 압박은 시간이 중요합니다.

간경변이 있다면 상의 없이 먹지 말 것: 소염진통제(이부프로펜 등), 수면제·진정제, 임의의 한약·즙·건강기능식품. 진통제는 치료팀이 정한 종류·용량으로만. **변비**는 간성뇌증을 악화시킬 수 있어 관리합니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 영상 판독지 받기 ② 간암 진료팀(소화기내과·간담체외과·영상의학과) 예약 ③ 항바이러스제 복용 확인.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ CT·MRI 판독지(LR 범주)와 영상 CD
- ☐ 간암 다학제 진료 가능한 진료팀 예약
- ☐ B형간염 약(항바이러스제)을 먹고 있다면 **절대 임의로 끊지 않기**, 복용 여부를 기록

이번 주 할 일

- ☐ 혈액검사(간기능, 간암 종양표지자 AFP·PIVKA-II, 혈소판), 흉부 CT, 필요 시 뼈스캔
- ☐ 위내시경(정맥류 확인 — 일부 전신치료 전 필수)
- ☐ 음주 중이라면 금주 지원 요청 — 끊기 어렵다는 것도 치료팀에 말해도 됩니다
- ☐ 가족 B형간염 검사·예방접종 상의
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내; **영상 진단 간암의 등록 기준**을 원무과에 확인)

오늘 물어볼 질문

1. 추가 검사(조직검사·내시경)가 필요한가요?
2. 간염 치료는 어떻게 계속하나요?
3. 다학제 진료에서 치료를 상의하나요?

4장. 간기능과 병기

30초 요약: 간암 치료의 핵심 개념은 "얼마나 남은 간이 치료를 견딜 수 있는가"입니다.

평가	주요 요소	환자가 이해할 점
Child-Pugh(A·B·C)	빌리루빈·알부민·혈액응고·복수·간성뇌증	A가 가장 좋음. B·C면 치료 선택이 좁아짐
ALBI 등급	알부민·빌리루빈	간기능을 더 세밀하게 나눔
전신상태(ECOG)	일상생활 정도	치료 강도 결정
문맥압항진	정맥류·혈소판·비장 크기	수술 가능성에 영향

병기 이름이 두 개일 수 있습니다

- **BCLC(0·A·B·C·D):** 종양 + 간기능 + 전신상태로 단계를 나누며 **치료 방향과 연결**됩니다.
- **mUICC(I~IV):** 한국에서 많이 쓰는 종양 범위 중심 병기.
- mUICC는 ① 종양이 1개 ② 2cm 이하 ③ 혈관·담관 침범 없음, 세 조건 중 몇 개를 만족하는지로 I~III기를 나누고, 하나도 해당하지 않거나 림프절·다른 장기 전이가 있으면 IV기입니다.

BCLC	쉬운 뜻	흔한 치료 방향(국내 진료 차이 있음)
0·A(초기)	작은 단일~소수 종양, 간기능 양호	절제·고주파/극초단파 소작·이식
B(중간기)	여러 개, 혈관 침범·전이 없음	TACE(경동맥화학색전술) 중심, 일부 절제· 방사선·전신치료
C(진행기)	혈관 침범 또는 전이	전신치료, 국내에서는 TACE + 방사선 병합도 흔함
D(말기 간기능)	간기능이 많이 나쁨	이식 평가 또는 증상 조절 중심

■ **완전판에서 이어집니다** — 병리보고서 볼 것, 판독지 용어 사전

내 기록: Child-Pugh _ · **ALBI** _ · BCLC _ · **mUICC** _ · AFP _ · **PIVKA-II** _ ·
간염 ☐ B ☐ C ☐ 없음 · 항바이러스제 _____

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 치료 경로 지도

치료	누구에게(예)	기억할 점
간절제	간기능 양호, 남은 간이 충분	문맥압항진이 있으면 신중
간이식	기준 내 종양 + 간기능 저하	국내에는 생체간이식 비중이 큼
고주파· 극초단파 소작	작은 종양(대개 3cm 이하. 3~5cm는 TACE와 함께 하는 병합치료를 검토)	짧은 입원
TACE(경동 맥화학색전 술)	중간기	반복 시행 가능
TARE(방사 선색전술)	일부	보통 두 번(사전 평가 → 치료). 국내는 2020년 말부터 건강보험 부분 급여 — 본인 부담 확인
방사선 (SBRT· 양성자)	소작이 어렵거나 혈관 침범	양성자는 일부 센터
전신치료	진행기, 국소치료 불응	아래 6장

- **수술·소작 후 보조 면역치료:** 추적 결과 이득이 불확실해, 현재 **표준으로 확립된 보조 전신치료는 없다**고 보는 것이 일반적입니다. 임상시험으로 논의될 수 있습니다.
- TACE에 전신치료를 함께하는 전략이 연구되고 있으며 표준 여부·국내 허가·급여는 최신 근거 확인이 필요합니다.

- 시술 전 **혈액을 묽게 하는 약**을 먹고 있다면 알려세요. 국소치료 때도 **B형간염 재활성화**에 주의해 항바이러스제를 유지합니다.

6장. 전신치료

30초 요약: 1차 전신치료는 **면역 + 혈관신생억제 / 면역 + 면역 / 면역 단독 / 먹는 표적치료제(TKI)** 범주가 있습니다(국내 허가·급여 확인 필요). 간기능이 치료 선택을 좌우합니다.

범주	대표 예시	기억할 점
면역 + 혈관신생억제	아테졸리주맙 + 베바시주맙	시작 전 내시경으로 정맥류 확인·치료
면역 + 면역	더발루맙 + 트레멜리무맙 등	면역 관련 부작용
면역 단독	더발루맙 등(국내 허가·급여 확인 필요)	병용이 어려운 일부 환자
먹는 표적치료제	렌바티닙·소라페닙	고혈압·손발 피부·설사·피로
2차 이후	다른 TKI, 면역치료 등	1차에 따라 다름

간기능이 많이 떨어져 있다면

- Child-Pugh **A**: 표준 전신치료 대상인 경우가 많음
- Child-Pugh **B**: 개별적으로 선택(근거 제한, 담당의 판단)
- Child-Pugh **C**: 항암보다 간기능·증상 관리, 이식 가능성 평가가 우선

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

시술 후 신호등

30초 요약: TACE·소작 뒤 수일간 미열·통증·메스꺼움(색전후증후군)은 흔합니다. 오래가거나 심해지면 연락하세요.

구분	증상
● 괜찮은 것	수일 내 가라앉는 미열·오른쪽 윗배 통증·메스꺼움·피로
▲ 전화할 것	퇴원 후에도 고열 지속·재발, 오한, 진통제로 조절 안 되는 통증, 황달, 소변량 감소
■ 응급실	갑작스러운 심한 복통과 어지럼, 토혈·흑변, 의식 변화

- 간경변이 있어도 **단백질을 스스로 줄이지 마세요**(생선·달걀·두부, 늦은 저녁 간식). 복수가 있으면 저염이 특히 중요합니다.

■ 완전판에서 이어집니다 — 간경변 식단 요령, 간성뇌증 관찰 카드(보호자용), 7일 시술 후 일지

추적

- 치료 후 수개월 간격으로 영상(CT·MRI)과 종양표지자를 확인합니다. 간암은 남은 간에서 새로 생길 수 있어 **평생 정기 추적**이 중요합니다.
- 국내 자료로는 치료 뒤 첫 2년은 2~6개월, 그 뒤에도 3~6개월 간격으로 영상과 종양표지자 검사를 이어 갑니다. 절제 뒤 5년 안에 절반 안팎에서 재발하고 대부분 간 안에서 생기므로, 추적 일정을 거르지 않는 것이 중요합니다.
- 간염 치료와 간경변 관리를 계속합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ **완전판에서 이어집니다**

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀝니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

 **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 영상 진단인가요, 조직 진단인가요? 2. 간기능(Child-Pugh·ALBI)은요? 3. 병기(BCLC·mUICC)는요? 4. 절제·이식·소작이 가능한가요? 5. TACE·방사선은 어떤가요? 6. 전신치료라면 무엇이고 정맥류 내시경이 필요한가요? 7. 간염 치료는 어떻게 계속하나요? 8. 간경변이 있다면 피해야 할 약은요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 임상시험이 있나요?

내 간암 한 장 요약

항목	내 기록
진단 방법	영상(LR-__) / 조직
크기·개수·혈관 침범	_____
간기능	Child-Pugh _ · ALBI _
병기	BCLC _ · mUICC _
종양표지자	AFP _ · PIVKA-II _
간염	B / C / 없음 · 약 _____
첫 치료	절제 / 이식 / 소작 / TACE / 방사선 / 전신치료
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 간기능은? ② 어떤 치료가 가능한가요? ③ 간염 약은 계속 먹나요?

완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 간암 용어사전
- 간암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Hepatocellular Carcinoma, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘 문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 대한간암학회·국립암센터 간세포암종 진료 가이드라인(최신판 확인), 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 간암 정보, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 실지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).

- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 병리보고서 볼 것, 판독지 용어 사전
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 간경변 식단 요령, 간성뇌증 관찰 카드(보호자용), 7일 시술 후 일지
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 간암 용어사전

- 간암 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>